राज्यातील आदिवासी भागातील आरोग्य विषयक सर्व समस्यांचा अभ्यास करुन त्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या राज्यस्तरीय समितीच्या अहवालातील शिफारसींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी **राज्यस्तरीय अंमलबजावणी समिती** गठीत करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
सार्वजनिक आरोग्य विभाग
शासन निर्णय क्रमांकः समिती-२०२६/प्र.क्र.१२/आदिवासी कक्ष,
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत,
०८वा मजला, नवीन मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१
दिनांक: ०६ मे, २०२६

वाचा:-

१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र. १६/समन्वय-२, दिनांक २७/०३/२०२५

२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन शुध्दीपत्रक, क्रमांक: संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र. १६/समन्वय-२, दिनांक ०९/०४/२०२५

**प्रस्तावना:-**

राज्यातील आदिवासी / दुर्गम भागात उत्तम आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी सध्या अनेक आव्हाने/अडचणी आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने तज्ञ मनुष्य बळाची उपलब्धता, माता मृत्यू, बाल मृत्यू, अर्भक मृत्यू, कमी वजानाचे बालक जन्मास येणे तसेच मलेरीया, डेंगू, सिकलसेल, ॲनिमिया इत्यादी आजारांचे वाढते प्रमाण त्याचप्रमाणे असंसर्गजन्य आजार उदा. मधूमेह, कॅन्सर इत्यादींचा समावेश आहे. याशिवाय सदर भाग डोंगर दऱ्यांचा असल्यामुळे रस्ते, वीजपुरवठा, पाणी पुरवठा इत्यादी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यामध्ये अनेक अडचणी येत आहेत.

२. वरील सर्व बाबींचा सर्वंकष अभ्यास करुन आदिवासी भागातील आरोग्य सेवा व इतर मुलभूत पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी आवश्यकत्या उपाययोजना सुचविण्याकरीता वाचा मधील अ.क्र. १ येथील दिनांक २७ मार्च, २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीमध्ये जिल्हास्तरावर प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या विविध विभागातील जिल्हाप्रमुख व कार्यालय प्रमुखांचा समावेश करण्यात आला होता.

३. उक्त राज्यस्तरीय समितीने त्यांना नेमूण दिलेल्या वरील विषयाच्या अनुषंगाने आवश्यकतेनुसार आदिवासी बहूल जिल्ह्यात विविध ठिकाणी प्रत्यक्ष भेटी देवून आरोग्य सेवा व इतर मुलभूत सुविधांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. तसेच जिल्हास्तरावरील/ ग्रामीण भागातील विविध शासकीय कार्यालयातील संबंधीत अधिकारी, खाजगी संस्था, रहिवासी, स्वयंसेवी संस्था व तज्ञ व्यक्तींशी वेळोवेळी वरील विषयाच्या अनुषंगाने संवाद केला.

त्याचप्रमाणे देशातील ज्या राज्यामध्ये आदिवासी बहूल व दुर्गम भाग आहे, अशा राज्यांना प्रत्यक्ष भेटी देवून त्या राज्यांमध्ये सदर समस्यांच्या अनुषंगाने कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत वा करण्यात येत आहेत, याबाबतचा सखोल अभ्यास केला आहे.

४. उक्त राज्यस्तरीय समितीने त्यांचा अहवाल दिनांक ०९.०२.२०२६ रोजीच्या पत्रान्वये, सार्वजनिक आरोग्य विभागास सादर केला आहे.

सदर अहवालाचे अवलोकन केले असता, यामध्ये आदिवासी भागातील रस्ते, शिक्षणव्यवस्था, साक्षरता, पाण्याची व्यवस्था, स्वच्छता गृहे, उपजिविकेची साधने, आर्थिक परिस्थिती, आरोग्य विषयक समस्या, माता आणि बाल आरोग्य, माता व बालकांमधील कुपोषण, अनेक संसर्गजन्य आजार, आरोग्य विषयक समस्यांसंदर्भात स्थानिक वैद्यांशी संवाद, आदिवासी भागातील आरोग्य सेवांचा पुरवठा, आरोग्य माहिती प्रणाली, आरोग्य विषयक सेवा देणाऱ्या मनुष्यबळाचे बळकटीकरण, दुर्गम आदिवासी भागातील आपत्कालीन वाहतुकीचे बळकटीकरण, आदिवासी आरोग्य प्रशासनासाठी स्वतंत्र धोरणात्मक निर्णयाची आवश्यकता इत्यादी विविध बाबींवर विश्लेषनात्मक माहिती नमूद करुन आदिवासी भागातील समस्या व आव्हानांसंदर्भात ठोस उपाय योजना सुचविलेल्या आहेत. सदर राज्यस्तरीय समितीच्या संकल्पनेतून या शिफारशी प्राप्त झाल्या असून वरील विषयासंदर्भात त्यांचा सखोल अभ्यास झालेला आहे. त्यामुळे त्याच समितीमधील अधिकाऱ्यांकडून शिफारशींची प्रभावी अंमलबजावणी करणे सुलभ होईल.

५. सबब, उक्त राज्यस्तरीय समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारसींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी समर्पितरित्या कार्य करण्याकरिता **राज्यस्तरीय अंमलबजावणी समिती** (State Level Implementing Committee) गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

**शासन निर्णय** -

६. वर नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या राज्यस्तरीय समितीच्या अहवालातील शिफारसींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे **राज्यस्तरीय अंमलबजावणी समिती** (State Level Implementing Committee) गठीत करण्यात येत आहे:-

| | |
|---|---|
| १.डॉ.मित्ताली सेठी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार, | अध्यक्ष. |
| २.श्रीम. मिनल करनवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगाव, | सदस्य. |
| ३. श्री.सुहास लक्ष्मण गाडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, गडचिरोली, | सदस्य. |
| ४.श्री. मुरुगणाथन एम., मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, गोंदिया, | सदस्य. |
| ५. श्रीम. मेघना कवली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड, | सदस्य. |
| ६.डॉ. कपिल आहेर, उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक, | सदस्य सचिव. |

७. **समितीची कार्यकक्षा-**

समितीची कार्यकक्षा राज्यातील सर्व आदिवासी जिल्ह्यांसाठी (१६ जिल्हे ) राहील.

८. **उक्त समितीची भूमिका, कार्ये/ जबाबदाऱ्या व अधिकार :-**

उक्त समितीची भूमिका, कार्ये/ जबाबदाऱ्या व अधिकार खालीलप्रमाणे राहतील:-

(१) राज्यातील आदिवासी क्षेत्रांतील आरोग्य सेवा, पोषण-आहार, सिकल सेल आजार, मनुष्यबळ उपलब्धता, तसेच आरोग्य सेवा उपलब्धता, माहिती प्रणाली व आंतरविभागीय समन्वय यासंबंधित प्राधान्यक्रम निश्चित करून अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेचा नियमित आढावा घ्यावा.

(२) शिफारशींच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी, प्रशासकीय मर्यादा किंवा धोरणात्मक बाबींसंदर्भात आवश्यकतो प्रस्ताव, सूचना व शिफारसी प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग किंवा प्रकरण परत्वे संबंधित सक्षम अधिकारी यांच्याकडे सादर कराव्यात.

(३) राज्यस्तरीय समितीच्या अहवालातील शिफारशीमधील बाबी जिल्हा स्तरावरील, विभागीय स्तरावरील विविध विभागांशी संबंधित आहेत. त्यामुळे आवश्यकतेनुसार संबंधित विभाग प्रमुख, क्षेत्रीय विभागीय अधिकारी किंवा जिल्हास्तरीय अधिकारी यांच्याकडून आवश्यक माहिती, आकडेवारी किंवा अहवाल मागविण्याचे पूर्ण अधिकार उक्त समितीस राहतील.

(४) सदर समिती आवश्यकतेनुसार आदिवासी क्षेत्रांमध्ये क्षेत्रभेटी, फोकस ग्रुप चर्चा, आढावा बैठका किंवा परिसंवाद, चर्चा सत्र आयोजीत करून प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेईल.

(५) राज्यस्तरीय समितीच्या अहवालातील शिफारशींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी अंमलबजावणी प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक सूचना, कार्यपद्धती किंवा सुधारणा, उपाय योजना सुचविण्याचे अधिकार उक्त समितीस असतील.

(६) समिती आवश्यकतेनुसार विशिष्ट विषयांवर उपसमित्या किंवा कार्यगट, अभ्यास गट स्थापन करून त्यांच्यामार्फत सविस्तर अभ्यास किंवा अंमलबजावणीस सहाय्य घेऊ शकेल.

(७) शासनाच्या कोणत्याही अधिकारांना बाधा न आणता राज्यस्तरीय समितीच्या अहवालातील शिफारशींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी धोरणात्मक बदल, कार्यक्रम सुधारणा किंवा नवीन उपक्रम यासंबंधीचे आवश्यकते प्रस्ताव शासनास सादर करण्याचे अधिकार उक्त समितीस राहतील.

९. **समितीचा कार्यकाल:**

(१) समितीचा कार्यकाल हा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून पुढील तीन (३) वर्षाचा राहील.

(२) त्यानंतर आवश्यकतेनुसार उक्त समितीस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात येईल.

(३) उक्त समितीमधील अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीने, बदलीने किंवा इतर कोणत्याही कारणास्तव राज्यात इतरत्र पदस्थापना झाली तरीही, त्यांनी सदर समितीचे काम विहीत कालावधी पूर्ण होईपर्यंत करावयाचे आहे.

१०. **बैठका व आढावा:**

(१) सदर समितीची बैठक प्रत्येक महिन्याला किमान एकदा आयोजित करण्यात यावी.

(२) समितीस आवश्यकतेनुसार बैठकीसाठी संबंधित कोणत्याही अधिकारी, संस्था प्रतिनिधी किंवा इतर संबंधित व्यक्तींना निमंत्रित करण्याचा अधिकार राहील.

(३) समितीच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक तीन महिन्यांतून किमान एकदा आढावा बैठक आयोजित करण्यात येईल.

**११ प्रशासकीय व वित्तीय बाबी:**

(१) समितीचे कामकाज सुलभ होण्यासाठी आवश्यकतेप्रमाणे प्रशासकीय व समन्वय सहाय्य सार्वजनिक आरोग्य विभाग व त्याच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही कार्यालयामार्फत उपलब्ध करून घेण्याचे अधिकार समितीस असतील.

(२) समितीच्या बैठका किंवा अधिकृत कामकाजासाठी उपस्थित राहणाऱ्या सदस्यांना प्रचलित शासकीय नियमांनुसार प्रवास भत्ता व दैनंदिन भत्ता अनुज्ञेय राहील. सदरचा खर्च बैठकीस उपस्थित राहणाऱ्या संबंधितांच्या कार्यालयाकडे उपलब्ध असलेल्या निधीतून करण्यात यावा.

(३) समितीच्या कामकाजाच्या अनुषंगाने आवश्यकत्या वित्तीय बाबीं संदर्भातील प्रस्ताव प्रचलित शासन धोरणानुसार सक्षम प्राधिकरणास सादर करण्यात येतील.

१२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक **२०२६०५०६१३४३३७९९१७** असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

VIKAS TULSHIRAM KADAM

Digitally signed by VIKAS TULSHIRAM KADAM
DN: cn=VIKAS TULSHIRAM KADAM, o=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, email=vikas.kadam@nic.in, c=IN
Date: 2026.05.06 15:30:22 +05'30'

(विकास तु.कदम)

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१.मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई.
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
३. मा.उप मुख्यमंत्री तथा मंत्री (नगर विकास, गृह निर्माण) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
४. मा.उप मुख्यमंत्री तथा मंत्री (राज्य उत्पादन शुल्क, क्रिडा व युवक कल्याण, अल्पसंख्याक कल्याण आणि औफाक) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
५. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
६. विभागीय आयुक्त (सर्व).
७. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, रा.आ. अ., मुंबई.
८. मा.मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
९.मा.मंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
१०.मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
११. . मा.राज्यमंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
१२. जिल्हाधिकारी/आयुक्त, महानगरपालिका (सर्व).
१३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व).
१४. संचालक, आरोग्य सेवा १ व २ आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई/पुणे.
१५. डॉ.मित्ताली सेठी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार.
१६. श्रीम.मिनल करनवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगाव.

१७. श्री.मुरुगणाथन एम., मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, गोंदिया.
१८. श्रीम.मेघना कवली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड.
१९. श्री.सुहास लक्ष्मण गाडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, गडचिरोली.
२०. डॉ.कपिल आहेर, उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक.
२१. सह संचालक / उप संचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळे (सर्व).
२२. जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालये (सर्व).
२३. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व).
२४. प्रधान सचिव, (सार्वजनिक आरोग्य विभाग) यांचे स्वीय सहायक.
२५. उप सचिव, (आदिवासी कक्ष) यांचे स्वीय सहायक.
२६. सर्व कार्यासने, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
२७. निवड नस्ती (आदिवासी कक्ष).